医療クリニック（診療所）BPO設計

スコープ: 無床〜19床の診療所（内科・整形外科・皮膚科・眼科・耳鼻科等、3〜30名規模）
攻略優先度: B（歯科の次に展開）
ゲノム系統: 歯科系（レセプト+予約+採用の同構造）
実装対象: #1 レセプト点検AI のみ。他は拡張ロードマップ

---

0. エグゼクティブサマリー

```
事業所数: 約10万（全国の診療所）
市場規模: 約35兆円/年（国民医療費の約30%が診療所）
DX進捗: 電子カルテ普及率50%程度。レセコンはほぼ全施設に導入済み

クリニックは：
  ・レセプト査定で毎月減収。診療科ごとにルールが異なり複雑
  ・院長が月末にレセプトチェックで5-10時間消費
  ・予約管理が電話中心。患者のリコール管理ができていない
  ・看護師の採用が困難（求人倍率2.4倍）
  ・施設基準の維持管理が属人化
 → 歯科のレセプト点検と同構造だが、診療科×算定ルールの組み合わせが桁違いに多い
```

8モジュール全体像

#	モジュール	Tier	月額価値	実装
1	レセプト点検AI	★キラー	¥5-15万	← 実装対象
2	患者予約・リコール	Tier1	¥3-5万	拡張ロードマップ
3	紹介状・診断書作成支援	Tier1	¥2-3万	拡張ロードマップ
4	経理・給与	Tier2	¥2-3万	拡張ロードマップ
5	院内感染・医療安全	Tier2	¥1-2万	拡張ロードマップ
6	採用支援（看護師）	Tier2	¥2-3万	拡張ロードマップ
7	施設基準管理	Tier3	¥1-2万	拡張ロードマップ
8	届出・許認可	Tier3	¥1-2万	拡張ロードマップ

---

1. レセプト点検AI（★実装対象）

1.1 問題の本質

```
医科レセプトの現状:
  ・診療報酬点数表は約5,000項目
  ・診療科ごとに算定ルールが大きく異なる（内科vs整形vs眼科...）
  ・薬剤×病名の適応チェックが膨大
  ・検査×病名の適応、回数制限の管理
  ・DPC（包括払い）対象病院と出来高払いの違い

  → 歯科より算定ルールが桁違いに複雑
  → だからこそAI化の価値が高い
```

1.2 支払いロジック

```
■ 直接効果①：査定損失の回避
  月間請求額1,000万円 × 査定率0.3%改善 = 月3万円 = 年36万円
  月間請求額2,000万円の医院なら = 月6万円 = 年72万円

■ 直接効果②：算定漏れの防止
  特定疾患療養管理料、外来管理加算、在宅時医学総合管理料等
  → 算定漏れ月3-10万円 = 年36-120万円

■ 直接効果③：院長のレセプトチェック時間削減
  月5-10時間 × 時間単価20,000円 = 月10-20万円 = 年120-240万円

■ 合計効果：年192-432万円
  → BPO月8万円（年96万円）で ROI 2.0〜4.5倍
```

1.3 歯科レセプトとの差分（ゲノム差分）

項目	歯科	医科（クリニック）
点数表の項目数	約1,500	約5,000
診療科の分岐	なし（歯科のみ）	内科/整形/皮膚/眼科/耳鼻科等で大きく異なる
薬剤チェック	限定的	膨大（薬剤×適応病名×禁忌×用量）
DPC	対象外	有床19床以下は出来高（対象外が多い）
主な加算	か強診、SPT等	特定疾患管理料、在宅系加算、生活習慣病管理料等
共通エンジン	ルールベースチェック→AI予測→レポート生成（同一）	

→ エンジンは歯科と同一。ゲノム（算定ルールDB）を診療科別に追加する設計。

1.4 診療科別の主な算定ポイント（ゲノムに詰める内容）

内科

- 特定疾患療養管理料（月2回まで、対象疾患の確認）
- 生活習慣病管理料（糖尿病・高血圧・脂質異常症）
- 在宅時医学総合管理料（訪問診療を行う場合）
- 薬剤の適応病名チェック（処方薬×病名の対応）

整形外科

- リハビリテーション料（疾患別リハの算定上限日数）
- 運動器リハ/脳血管リハの区分管理
- 注射料（関節注射、トリガーポイント注射）

皮膚科

- 特定疾患処方管理加算
- 皮膚科特定疾患指導管理料
- 光線療法の算定

眼科

- 精密眼底検査、精密眼圧測定
- 視力検査の回数制限
- コンタクトレンズ検査料

1.5 業務フロー

```
（歯科のレセプト点検と同一フロー。差分は算定ルールDBのみ）

【日次】　診療→カルテ入力→レセコン入力→会計
【月初】　前月分レセプト一括出力→点検→院長最終チェック
【毎月10日】　オンライン請求（支払基金・国保連）
【翌月〜翌々月】　返戻・査定の確認→再請求
```

1.6 課題テーブル

課題	具体的な問題	影響額（年間）	発生頻度
院長がチェックに張り付き	月末〜月初の5-10時間	機会損失120-240万円	毎月
病名漏れ	処方薬に対応する病名がない→査定	36-72万円の減収	月数件〜数十件
算定漏れ（取れるのに取っていない）	管理料・加算の算定漏れ	36-120万円の逸失	毎月
薬剤の適応外処方	適応病名のない薬剤処方→査定	同上	月数件
事務員の属人化	レセプトチェックできるのは1人	事業リスク	常時
診療報酬改定への追従	2年ごとの改定。新ルールの把握漏れ	誤請求リスク	2年ごと

2〜8. 拡張ロードマップ

> 以下は#1モジュール（レセプト点検AI）のPMF確認後に実装。

② 患者予約・リコール（Tier1 / ¥3-5万）

- 慢性疾患（糖尿病・高血圧）のフォローアップ管理
- 歯科の「リコール管理」パターンの横展開
- 予約枠最適化（診療内容別の所要時間推定）

③ 紹介状・診断書作成支援（Tier1 / ¥2-3万）

- 医師が診療後に書類作成で月20-40h
- LLMで下書き生成、医師は確認・修正のみ

- 士業の「書類作成支援」パターンの横展開

④ 経理・給与（Tier2 / ¥2-3万）

- 保険診療+自費+健診の収益管理
- 歯科の「経理・給与」パターンの横展開

⑤ 院内感染・医療安全（Tier2 / ¥1-2万）

- チェックリスト+報告書+保健所対応
- 歯科の「院内感染管理」パターンの横展開

⑥ 採用支援・看護師（Tier2 / ¥2-3万）

- 看護師求人倍率2.4倍。紹介料60-100万/人
- 歯科の「採用支援（衛生士）」パターンの横展開

⑦ 施設基準管理（Tier3 / ¥1-2万）

- 在宅療養支援診療所等の基準充足チェック
- 歯科の「届出・許認可管理」パターンの横展開

⑧ 届出・許認可（Tier3 / ¥1-2万）

- 保険医療機関指定更新
- 歯科の「届出・許認可管理」パターンの横展開

セキュリティ・コンプライアンス

- 要配慮個人情報（患者データ）→ 3省2ガイドライン準拠必須（歯科と同一要件）
- 全アクセスをaudit_logsに記録
- テナント分離（company_idベースのRLS）

競合環境

サービス	月額	強み	弱み
レセプト点検ASP各社	¥2-5万	ルールベースチェック	AI予測なし
メディコム（PHC）	レセコン同梱	レセコン最大手	チェック機能は基本的
ORCA（日医標準）	無料〜	日医推奨。普及率高い	点検機能は最低限
AI-SORA等AIレセプト	¥3-10万	AI査定予測	単機能。業務全体を通せない

差別化: 既存は「レセプト単体チェックツール」。シャチョツーは歯科で実証済みのエンジンを医科に展開し、レセプト+予約+採用+経理を一気通貫。